

1. Portada

Diagnóstico y tratamiento del episodio depresivo y del trastorno depresivo recurrente en adultos. Guía de Práctica Clínica (GPC)

Institución emisora: Ministerio de Salud Pública.

Año: 2017

Fuente: capítulo 13 «Evidencias y recomendaciones» de la guía original. Documento reorganizado para uso como corpus de recuperación de información; el contenido clínico proviene íntegramente de la guía original. La guía usa grados de recomendación A-D y etiquetas fuerte/débil; en el texto fuente no siempre es posible asignar sin ambigüedad cada grado a cada recomendación, por eso este documento indica la fuerza solo donde es inequívoca.

2. Resumen

Esta guía establece el diagnóstico y el tratamiento del episodio depresivo y del trastorno depresivo recurrente en adultos (mayores de 18 años). Adopta un modelo de atención escalonado de cuatro pasos: (1) reconocimiento, evaluación y manejo inicial; (2) depresión leve; (3) depresión moderada y grave; (4) depresión con alto riesgo para la vida. Usa los criterios CIE-10 para el diagnóstico y la gravedad, recomienda psicoterapia (terapia cognitivo conductual de primera línea) para la depresión leve y la combinación de antidepresivo y psicoterapia para la moderada y grave, con ISRS como primera elección farmacológica. Incluye valoración y manejo del riesgo suicida, seguimiento, depresión resistente, embarazo y lactancia, adulto mayor, y criterios de referencia y contrarreferencia. No cubre la depresión posparto.

3. Índice

N.º	Sección
1	Portada
2	Resumen
3	Índice
4	Abreviaturas
5	Glosario
6	Epidemiología y factores de riesgo de la depresión
7	Diagnóstico: de los síntomas a la clasificación de gravedad
8	Tratamiento farmacológico de la depresión
9	Tratamiento no farmacológico y manejo: psicoterapia, riesgo suicida y situaciones especiales
10	Seguimiento, pronóstico y criterios de referencia

4. Abreviaturas

Sigla	Significado
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión
TCC / TCCG	Terapia cognitivo conductual / TCC grupal
TIP	Terapia interpersonal
ISRS	Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (fluoxetina, sertralina, paroxetina)
ATC	Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina)
NaSSA	Antidepresivo noradrenérgico y serotoninérgico específico (mirtazapina)
IRSN / duales	Inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (venlafaxina)
IMAO	Inhibidores de la monoaminoxidasa
TEC	Terapia electroconvulsiva
CNMB	Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos
TSH / T4	Hormona estimulante de la tiroides / tiroxina

5. Glosario

Episodio depresivo: cuadro de al menos dos semanas con humor depresivo, pérdida de interés o falta de energía, que cumple los criterios CIE-10; se clasifica en leve, moderado o grave (con o sin síntomas psicóticos).

Trastorno depresivo recurrente: episodio depresivo actual más al menos un episodio previo separado por al menos dos meses libres de alteración significativa del ánimo, sin criterios de manía o hipomanía en ningún momento de la vida.

Modelo escalonado: modelo de atención en el que se ofrecen primero las intervenciones más efectivas y menos intrusivas, y se pasa al siguiente nivel si el paciente no se beneficia o las rechaza.

Síndrome de discontinuación: síntomas por suspensión brusca de un antidepresivo (mareo, náuseas, ansiedad, cefalea, cambios en el ánimo, inquietud, insomnio, sudoración, parestesias).

Riesgo suicida: término general para el riesgo de ideación suicida, comunicación suicida (amenaza o plan) o conducta suicida (incluye autolesiones, gestos, intento y suicidio).

6. Epidemiología y factores de riesgo de la depresión

El capítulo de recomendaciones de la guía no presenta cifras de prevalencia o incidencia de la depresión. Sí define a quiénes se debe considerar de mayor riesgo de presentar un episodio depresivo al evaluar a cualquier paciente mayor de 18 años en consulta (fuerte a favor):

- Historia previa de episodio depresivo e historia familiar de depresión.
- Problemas psicosociales: desempleo, separación conyugal, eventos vitales estresantes, violencia (maltrato).
- Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
- Consulta frecuente al sistema de salud.
- Enfermedades médicas crónicas, sobre todo con compromiso funcional (cardiovasculares, diabetes, dolor crónico, trastornos neurológicos).
- Historia de intentos de suicidio.
- Sedentarismo.

La sospecha de episodio depresivo debe ser alta ante síntomas físicos inexplicables, dolor crónico, fatigabilidad, insomnio, ansiedad y uso de sustancias. Los predictores de recurrencia y de respuesta al tratamiento se describen en la sección 10.

7. Diagnóstico de la depresión: de los síntomas a la clasificación de gravedad

Conducta según el escenario clínico

Escenario del paciente	Conducta según la guía
Adulto sin factores de riesgo ni síntomas	No se recomienda tamizaje rutinario de depresión en población general (dudas sobre su efectividad).
Adulto con consumo de alcohol u otras drogas	Realizar tamizaje de depresión.
Adulto con violencia intrafamiliar, enfermedad crónica, antecedentes propios o de familiares directos de depresión, abuso o maltrato físico o sexual	Realizar tamizaje de depresión.
Paciente con factores de riesgo y síntomas como insomnio, bajo estado de ánimo, anhedonia o ideación suicida	Sospechar depresión y aplicar los criterios diagnósticos CIE-10.
Paciente con síntomas depresivos	Confirmar con criterios CIE-10 (tabla siguiente); las escalas complementan pero no sustituyen la entrevista clínica. Descartar trastorno bipolar, comorbilidad física y mental, y causas médicas, por sustancias o medicamentos.
Adulto mayor con sospecha de depresión	Incorporar el estudio de deterioro cognitivo y otras comorbilidades frecuentes; considerar diagnóstico diferencial con demencias, hipotiroidismo, hipertiroidismo, cáncer de páncreas, enfermedad de Addison, tumores cerebrales, avitaminosis, desnutrición, Parkinson y fármacos.
Cualquier paciente adulto con diagnóstico de depresión	Evaluar el riesgo suicida. Si hay sospecha de intento de suicidio o riesgo de suicidio, referir a atención psiquiátrica inmediata.

Estudios de laboratorio

Se sugiere solicitar biometría hemática, glucemia basal, T4, TSH y otros exámenes según criterio médico a todo paciente con sospecha de depresión, para descartar otras enfermedades con síntomas depresivos. No existen exámenes paraclínicos específicos para diagnosticar depresión. Debe hacerse anamnesis detallada, examen físico y examen psicológico de salud.

Criterios diagnósticos CIE-10 de episodio depresivo

Criterio	Contenido
A. Generales	Duración de al menos dos semanas; no atribuible a abuso de sustancias psicoactivas ni a trastorno mental orgánico; sin síntomas hipomaníacos o maníacos suficientes para criterios de episodio maníaco o hipomaníaco en ningún período de la vida.
B. Al menos dos de tres	Humor depresivo anormal para el sujeto, la mayor parte del día y casi todos los días, poco modificado por el ambiente, durante al menos dos semanas; pérdida marcada de intereses o de la capacidad de disfrutar; falta de vitalidad, disminución de energía o aumento de la fatigabilidad.
C. Uno o más, hasta sumar al menos 4 síntomas en total	Pérdida de confianza y autoestima con sentimientos de inferioridad; autorreproches desproporcionados o culpa excesiva; pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o conducta suicida; disminución de la concentración y vacilación; cambios psicomotores (agitación o inhibición); alteración del sueño; cambios en el apetito con modificación del peso.

Gravedad del episodio depresivo (CIE-10)

Gravedad	Criterios
Leve	Criterios generales, al menos dos síntomas B y uno o más C, con suma de al menos 4 síntomas. Probablemente puede continuar la mayoría de sus actividades.
Moderado	Criterios generales, al menos dos síntomas B y síntomas C hasta sumar al menos 6. Probables dificultades para continuar las actividades ordinarias.
Grave sin síntomas psicóticos	Criterios generales, los tres síntomas B y síntomas C hasta al menos 8 en total. Síntomas marcados y angustiantes, pérdida de autoestima, culpa e inutilidad; comunes las ideas y acciones suicidas; síntomas somáticos importantes.
Grave con síntomas psicóticos	Cumple los criterios de episodio grave más ideas delirantes o alucinaciones (de contenido depresivo, de culpa, hipocondríaco, nihilístico, autorreferencial o persecutorio) o estupor depresivo.

Síndrome somático: pérdida de interés o de capacidad de disfrutar; ausencia de reacciones emocionales ante eventos que normalmente las provocan; despertar 2 o más horas antes de lo habitual; empeoramiento matutino del humor; enlentecimiento psicomotor o agitación objetivos; pérdida marcada de apetito; pérdida de peso del 5 % o más en el último mes; notable disminución de la libido.

Diagnóstico diferencial (síntomas que sugieren depresión)

Categoría	Causas
Patologías médicas	Endocrinas/metabólicas (patología tiroidea, diabetes, anemia severa, Cushing, Addison, porfiria); infecciosas (tuberculosis, virus de Epstein-Barr, VIH, sífilis terciaria); neurológicas (Alzheimer, esclerosis múltiple, Parkinson, ictus, epilepsia); neoplasias (carcinomatosis, cáncer de páncreas); dolor crónico.
Trastornos mentales	Trastorno de angustia, obsesivo compulsivo, bipolar, distimia, trastornos adaptativos, síntomas negativos de la esquizofrenia, consumo de tóxicos.
Medicamentos	Anticonvulsivantes, neurolépticos, estimulantes, anticonceptivos orales, glucocorticoides sistémicos.

Categoría	Causas
Consumo de drogas	Cocaína, pasta base de cocaína, anfetaminas, marihuana.

8. Tratamiento farmacológico de la depresión

El tratamiento farmacológico se administra a pacientes con depresión moderada o grave. Las únicas excepciones son la depresión leve con antecedente de depresión moderada o grave o con síntomas que persisten pese a otras intervenciones, con manejo individualizado por el especialista. La guía nombra los fármacos y sus líneas de tratamiento pero no lista dosis en mg ni frecuencias; remite las dosis y la evidencia de seguridad a su anexo 4, que no está en este documento. Los antidepresivos tardan de dos a ocho semanas en producir mejoría, no generan dependencia, y su retiro brusco puede causar síntomas de discontinuación.

Líneas de tratamiento y recomendaciones

Fármaco / decisión	Indicación	Fuerza	Observaciones
Primera línea: fluoxetina o sertralina (ISRS)	Adultos con depresión moderada o grave	Fuerte a favor	Los ISRS tienen la mayor evidencia y el mejor balance riesgo-beneficio. Seguimiento cuidadoso del riesgo de suicidio al iniciar.
Alternativa de primera línea: amitriptilina (ATC) o mirtazapina (NaSSA)	Según cuadro clínico y preferencias del paciente	Fuerte a favor	Mirtazapina no consta en el CNMB (requiere justificación técnica). Aumentar gradualmente la dosis de ATC y duales.
Adulto mayor o contraindicación de ATC	Primera línea: fluoxetina, sertralina o mirtazapina	Fuerte a favor	Evitar ATC en adultos mayores, cardiopatía o polifarmacia.
Sin mejoría en la tercera semana	Adherencia adecuada	Fuerte a favor	Ajustar la dosis o cambiar de antidepresivo.
Segunda línea	Cambio de antidepresivo	Fuerte a favor	Las alternativas de primera línea no prescritas (fluoxetina, sertralina, amitriptilina o mirtazapina).
Tercera línea	Falla de líneas previas	Fuerte a favor	Otros ATC, otros ISRS e inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina.
Cuarta línea: IMAO	Falla de líneas previas	Débil a favor	—
Benzodiacepinas (adicional al antidepresivo)	Ansiedad, insomnio o agitación	Grado D	No de rutina; no más de 2-3 semanas para evitar dependencia. Para insomnio, primero higiene del sueño y antidepresivo inductor del sueño.
Antidepresivos en depresión leve	No usar de rutina	Fuerte en contra	Riesgo-beneficio no lo amerita, salvo las excepciones indicadas arriba.
Inductores del sueño	No prescribir de rutina	Fuerte en contra	Riesgo de abuso y dependencia.

Fármaco / decisión	Indicación	Fuerza	Observaciones
Mantenimiento	Tras la remisión	Recomendado	Mantener al menos 6 meses tras la remisión (6-12 meses según el capítulo de seguimiento), con la misma dosis con que se logró la respuesta.
Suspensión	Fin del tratamiento	Fuerte a favor	Reducir la dosis gradualmente, normalmente en cuatro semanas (un mes), sobre todo con paroxetina y venlafaxina.
Depresión resistente: cambio	Sin respuesta a antidepresivo	Grado B	Primero otro ISRS u otro de segunda generación; luego ATC o potenciación con quetiapina o risperidona (más efectos adversos).
Embarazo y lactancia	Si se requiere farmacoterapia	Grado A	ISRS excepto paroxetina. En lactancia, evitar fármacos de vida media prolongada.
Trastorno bipolar con ideación suicida	Antidepresivo solo con estabilizador	Grado C	No usar antidepresivos como monoterapia; litio en adultos con bipolar y conducta suicida.

Efectos adversos frecuentes y precauciones

Grupo	Efectos adversos	Consideración
ATC	Taquicardia sinusal, hipotensión postural, alteraciones de la conducción cardíaca, sequedad bucal y ocular, retención urinaria, leve aumento del riesgo de crisis epilépticas	En adultos mayores, cardiopatía o polifarmacia, prescribir antidepresivos distintos de ATC.
ISRS	Diarrea (sobre todo sertralina), sangrado gastrointestinal, insomnio y ansiedad, disfunción sexual (mayor con paroxetina), náuseas	Con alto riesgo de sangrado (ancianos, AINE) usar protectores de la mucosa gástrica.
Duales (venlafaxina)	Hipertensión arterial (dosis altas), náuseas y vómito, disfunción sexual	Monitorizar la presión arterial.
Mirtazapina, trazodona, agomelatina	Aumento de peso (más con mirtazapina), somnolencia (también ATC)	—
Todos	Toxicidad en sobredosis, mucho mayor con ATC y duales	Con alto riesgo de suicidio usar otro tipo de antidepresivo como primera línea y precaución con ATC o duales.

Fases del tratamiento farmacológico

Fase	Objetivos	Tareas
Aguda	Obtener respuesta y disminuir la sintomatología	Individualizar según efectos adversos, comorbilidades y abuso de sustancias.
Continuación	Mantener la atenuación de síntomas, evitar recidivas y lograr mejoría funcional	Estimular la adherencia y la recuperación funcional gradual.
Mantenimiento	Lograr la remisión completa y evitar recurrencias	Estimular la recuperación funcional total e inserción social; evaluar necesidad de tratamiento adicional.

9. Tratamiento no farmacológico y manejo: psicoterapia, riesgo suicida y situaciones especiales

Modelo escalonado de atención

Paso	Situación	Intervención
1	Reconocimiento, evaluación y manejo inicial	Sospecha, tamizaje en grupos de riesgo, diagnóstico CIE-10 y evaluación de la gravedad y del riesgo suicida; información al paciente y a la familia.
2	Depresión leve	Psicoeducación como primera opción; seguimiento; ejercicio; psicoterapia breve si hay síntomas persistentes; sin antidepresivos de rutina.
3	Depresión leve con respuesta inadecuada, moderada y grave	Antidepresivo más psicoterapia (TCC o TIP); en grave, antidepresivo primero y luego intervención en crisis.
4	Depresión con alto riesgo para la vida	Valoración y clasificación del riesgo suicida, manejo en emergencias, hospitalización y atención especializada.

Depresión leve

- Explorar los eventos estresantes recientes; recomendar rutina cotidiana, hábitos saludables e higiene del sueño.
- Ejercicio de 30 a 45 minutos, tres veces por semana, durante 10 a 14 semanas (programa estructurado de actividad física).
- Psicoeducación como intervención psicoterapéutica de menor intensidad y primera opción (fuerte a favor).
- Tratamiento psicológico breve (TCC o terapia de solución de problemas) de 6 a 8 sesiones en 10-12 semanas para depresión leve a moderada; terapia psicodinámica de corto plazo de 16 a 20 sesiones en 4-6 meses (débil a favor).
- Si no hay mejoría o empeoran los síntomas en el seguimiento, referir a salud mental o psiquiatría (fuerte a favor). Con síntomas persistentes tras tres meses, iniciar TCC.

Depresión moderada y grave

- Combinar antidepresivos y psicoterapia (fuerte a favor). En depresión grave, iniciar primero el antidepresivo y, al haber respuesta, la intervención en crisis con el psicólogo.
- Reevaluar antes de 15 días tras iniciar el tratamiento en depresión moderada y antes de 8 días en la grave.
- Depresión resistente al tratamiento farmacológico: antidepresivo combinado con TCC.

Psicoterapias: línea, sesiones y duración

Terapia	Línea / indicación	Duración recomendada
TCC individual	Primera línea (fuerte a favor)	16-20 sesiones en 3-4 meses; en la sección de depresión moderada y grave el capítulo también indica 10-20 sesiones en 3-4 meses. Opcional dos sesiones por semana las 2-3 primeras semanas en moderada a grave y 3-4 sesiones de seguimiento en 3-6 meses.

Terapia	Línea / indicación	Duración recomendada
TIP individual	Segunda línea (fuerte a favor)	16-20 sesiones en 3-4 meses, con el mismo esquema opcional de sesiones intensivas y seguimiento.
Psicodinámica breve o terapia grupal	Tercera línea (débil a favor)	Psicodinámica corta: 16-20 sesiones en 4-6 meses.
TCC grupal	Alternativa	10-12 sesiones, 8-10 participantes, 12-16 semanas incluido el seguimiento.
TCC basada en conciencia plena (mindfulness)	Síntomas residuales, 3 o más episodios previos o alto riesgo de recaída; adicional a farmacoterapia (fuerte a favor)	Grupos de 8-15 pacientes; sesiones semanales de 2 horas por 8 semanas y 4 sesiones de seguimiento en 12 meses.
Terapia de pareja o familia	Problemas de pareja o familia que perpetúan los síntomas (débil a favor)	—

La psicoterapia está indicada en episodios depresivos moderados y graves, y también cuando hay contraindicación de manejo farmacológico (embarazo, lactancia, polifarmacia), buena respuesta previa a la psicoterapia, crisis psicosociales desencadenantes o síntomas cognitivos predominantes. Cada sesión dura entre 30 y 45 minutos, según la técnica.

Terapia electroconvulsiva y otras técnicas

La TEC debería considerarse en depresión grave, sobre todo si se necesita respuesta rápida por alta intencionalidad suicida, deterioro físico grave o falla de otros tratamientos. Se administra en entorno hospitalario de tercer nivel, por profesionales experimentados, tras evaluación física y psiquiátrica, con consentimiento informado y supervisión de un comité de bioética. No se recomiendan la estimulación del nervio vago fuera de la investigación ni la estimulación magnética transcraneal.

Riesgo suicida (paso 4)

Evaluar el riesgo suicida en todo paciente con depresión de forma periódica, mediante entrevista clínica (las escalas no la sustituyen). Factores que aumentan el riesgo: intentos previos, antecedentes familiares de conducta suicida, trastornos mentales comórbidos, abuso de sustancias, desesperanza, ansiedad, agitación, enfermedad física o dolor crónico, aislamiento, dificultades económicas o laborales y fácil acceso a armas, medicamentos o tóxicos. Preguntar de forma directa y empática, cuando el paciente se sienta comprendido: si siente que la vida no merece vivirse, si ha hecho planes, cómo y cuándo. Ante duda sobre el nivel de riesgo, asumir el nivel mayor.

Riesgo	Descripción	Conducta
Leve	Ideación suicida sin planes concretos ni intención evidente; puede rectificar	Referencia para evaluación psiquiátrica y psicológica, intervención en crisis, contrarreferencia asistida, contacto con redes sociales y familiares.
Moderado	Planes con ideación, posibles intentos previos, factores de riesgo adicionales	Referencia para intervención psiquiátrica, intervención en crisis y tratamiento farmacológico, evaluar el sostén familiar.
Grave	Preparación concreta para hacerse daño, más de dos factores de riesgo, desesperanza, rechaza el apoyo	Hospitalización (voluntaria o administrativa) en emergencias o en psiquiatría de corta estadía con vigilancia permanente; psicofármacos inmediatos si hay agitación o ansiedad extrema.
Extremo	Varios intentos con varios factores de riesgo; puede haber autoagresión	Hospitalización con medidas de contención y seguimiento especializado estricto; seguimiento por un equipo por no menos de 18 meses.

- En emergencias: atender dentro de la primera hora de llegada; el paciente debe ingresar sin armas, medicamentos ni tóxicos; adoptar medidas para evitar fuga, autoagresión o agresión a terceros; realizar valoración médica y psicosocial; solicitar evaluación psiquiátrica y psicológica.
- Hospitalizar en riesgo grave o extremo, ideación con trastorno mental grave, conducta autolítica grave reciente, plan elaborado, intencionalidad al final de la entrevista, situación social de riesgo, falta de apoyo o duda sobre la gravedad; también ante comunicación o conducta suicida.
- Restricción mecánica: solo temporal, si los beneficios superan los riesgos y no hay alternativa; evitar correas o cinturones; evaluación médica y psicológica continua y que no supere 48 horas.
- Al alta: datos de contacto válidos y un plan de manejo y seguimiento documentado.

Manejo especializado del riesgo suicida

- Psicoterapia: TCC una vez por semana (al menos al inicio), preferentemente individual; terapia dialéctico conductual en trastorno límite de personalidad; terapia interpersonal en mayores de 60 años.
- Antidepresivo ISRS de preferencia; en mayores de 60 años, ISRS con terapia interpersonal y seguimiento mantenido.
- Ansiolíticos al inicio del antidepresivo si hay ansiedad o agitación.
- Trastorno bipolar: litio en conducta suicida; ácido valproico o carbamazepina si se requiere anticonvulsivante. Esquizofrenia o esquizoafectivo con alto riesgo: clozapina. Trastorno límite de personalidad: carbamazepina de primera elección entre los anticonvulsivantes.
- TEC en depresión grave con necesidad de respuesta rápida por alta intencionalidad suicida.

Situaciones especiales

- Embarazo y lactancia: ponderar riesgos y beneficios; si se requiere fármaco, ISRS excepto paroxetina; vincular al cuidado prenatal; manejo multidisciplinario (neonatología, psicología, psiquiatría, ginecología). La guía no contempla la depresión posparto.
- Adulto mayor: considerar el curso de vida, comorbilidades y polifarmacia (interacciones); primera línea fluoxetina, sertralina o mirtazapina.
- Depresión resistente: revisar el diagnóstico, verificar el cumplimiento en dosis y tiempo, valorar comorbilidad y motivación; considerar TCC en respuesta inadecuada, recaídas o síntomas residuales; tratamiento combinado en depresión crónica o recurrente.

10. Seguimiento, pronóstico y criterios de referencia

Seguimiento

Situación	Seguimiento recomendado
Depresión leve	Citas cada 15 días durante tres meses consecutivos.
Tratamiento con antidepresivo	Seguimiento estrecho al menos las cuatro primeras semanas; primer control entre la segunda y tercera semana; luego controles mensuales al menos seis meses (fase de continuación). Reevaluar antes de 15 días (moderada) o de 8 días (grave).
Tras la remisión	Seguimiento por al menos seis meses desde la remisión total de síntomas; mantener el antidepresivo con la misma dosis entre 6 y 12 meses.

Situación	Seguimiento recomendado
Riesgo de recaída	Considerar antidepresivos hasta dos años si hay 3 o más episodios previos, síntomas residuales, comorbilidades, episodio grave con o sin psicosis, comorbilidad psiquiátrica o vulnerabilidad a estresores (débil a favor). Más de dos años: decisión individualizada con el psiquiatra.
Retiro del antidepresivo	Reducción gradual en un mes; evaluar al primer y al tercer mes para detectar reaparición de síntomas.
Prevención de recaídas	Ofrecer TCC en la fase de continuación si no se recibió en la fase aguda; puede darse junto con el fármaco o después de retirarlo.
Riesgo suicida extremo	Seguimiento por un equipo por no menos de 18 meses.

Pronóstico y predictores de respuesta

La guía no reporta cifras de remisión ni de supervivencia. Presenta predictores para ajustar el seguimiento y el tratamiento: **recurrencia**: tres o más episodios previos, síntomas residuales, problemas de salud comórbidos, episodio grave con o sin psicosis, otra comorbilidad psiquiátrica y vulnerabilidad a la recaída por estresores psicosociales; **mala respuesta**: trastornos de personalidad (pobre respuesta a la TCC), antecedente de intento de suicidio, comorbilidad con ansiedad y dolor físico; **buena respuesta**: respuesta temprana (menos de dos semanas), alta satisfacción con la vida y estado civil casado. También figuran IMC elevado, desempleo, depresión crónica, presencia de ansiedad e insomnio persistente, cuya columna no es legible en el texto fuente.

Signos de alarma

Ideación suicida, plan, intento o conducta suicida; síntomas psicóticos; compromiso del estado general (inanición, deshidratación, desnutrición); consumo de sustancias que ponga en riesgo la vida; falta de mejoría o empeoramiento en el seguimiento.

Criterios de referencia y contrarreferencia

- Hospitalización en servicios especializados de salud mental: intento de suicidio de cualquier tipo, ideación suicida estructurada con plan, síntomas psicóticos, compromiso del estado general, conductas de riesgo o daño autoinfligido con ideación suicida, consumo de sustancias que ponga en riesgo la vida, o estresores psicosociales que dificulten el manejo ambulatorio (sin red de apoyo, violencia, abuso, negligencia).
- Referencia a especialista: confirmación diagnóstica, comorbilidad psiquiátrica u orgánica, síntomas persistentes pese al tratamiento, riesgo suicida o de daño a otros, consumo problemático de alcohol u otras drogas, síntomas muy incapacitantes. Con ideación suicida la referencia debe ser urgente.
- Hospitalización de mediana estancia (hasta 21 días): síntomas depresivos con alto riesgo suicida o necesidad de ambiente controlado.
- Atención ambulatoria en primer nivel: sospecha y confirmación diagnóstica, diagnóstico presuntivo, tratamiento cuando el cuadro está compensado y con diagnóstico previo, y seguimiento.
- Contrarreferencia a atención ambulatoria: cuando se alcanzó estabilidad clínica con el máximo beneficio del tratamiento o hay remisión de la sintomatología aguda.